



BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIỀU TW
QUY HÒA
KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH

QUY TRÌNH QUẢN LÝ
THÔNG TIN

Mã tài liệu: **XN-QTQL 5.1.01**
Lần ban hành: **01**
Ngày ban hành: .../01/2026
Số trang: **09**

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	05/01/2026	10/01/2026	/01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Mục đích

Quy trình này quy định rõ trách nhiệm quản lý thông tin của Khoa Vi sinh-Miễn dịch

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho công tác quản lý thông tin của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt**4.1. Định nghĩa**

- Không có

4.2. Giải thích thuật ngữ

- Không có

4.3. Từ viết tắt

- QLTT: Quản lý thông tin

- XN: Xét nghiệm

- BM: Biểu mẫu

5. Nội dung thực hiện

STT	Nội dung công việc	Biểu mẫu/hồ sơ
5.1. Khái quát		
1	Khoa Vi sinh-Miễn dịch tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu người sử dụng, bao gồm quản lý dữ liệu và thông tin chứa trong máy tính và phi máy tính.	
2	Hệ thống được sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ hoặc phục hồi dữ liệu và thông tin xét nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu sau:	
2.1	Hệ thống thông tin được kiểm tra hoạt động bởi nhà cung cấp và Kỹ thuật viên trưởng.	
2.2	Khoa có hướng dẫn lập thành văn bản hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin và hệ thống tài liệu sẵn có	

	cho nhân viên sử dụng hàng ngày.	
2.3	Khoa bảo vệ sự truy cập trái phép như sau: Nhân viên chỉ được phép truy cập dữ liệu và thông tin bệnh nhân trên hệ thống HIS/LIS. Người trực chỉ được phép nhập dữ liệu và các kết quả xét nghiệm trong giờ trực.	
2.4	Hệ thống được bảo vệ chống lại giả mạo hoặc mất mát dữ liệu như sau: Nhân viên, khách,...không được truy cập vào hệ thống dữ liệu của khoa khi không có sự đồng ý của lãnh đạo khoa.	
2.5	Các hệ thống sử dụng để thu thập, xử lý, ghi chép, báo cáo, lưu trữ, ...vận hành phù hợp với các điều kiện hoạt động trong Khoa Vi sinh-Miễn dịch.	
2.6	Các dữ liệu được duy trì đảm bảo tính toàn vẹn và ghi chép các lỗi hệ thống và hành động khắc phục.	
2.7	Khoa đảm bảo kết quả được in ra từ máy tính hoặc từ bản điện tử được kiểm soát của Trưởng/Phó khoa. Khi một xét nghiệm mới hoặc các thông tin mới thì Khoa phải kiểm tra các thay đổi nhằm mục đích nhận thông tin trực tiếp từ Khoa.	
2.8	Trong trường hợp hệ thống thông tin gặp sự cố thì Khoa có biện pháp khắc phục để duy trì các dịch vụ của Khoa (ghi chép vào sổ nhận bệnh phẩm, trả kết quả, sổ kết quả,...)	
5.2. Phân quyền người dùng		
5.2.1. Quyền truy cập cho quản trị viên		
1	Đây là quyền truy cập cao nhất trong hệ thống quản trị dữ liệu, quản trị viên được toàn quyền truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu.	XN-BM 5.9.1/03
5.2.2. Quyền truy cập cho người quản lý.		

1	Đây là phân quyền truy cập cao sau quyền truy cập của quản trị viên, trong hệ thống quản trị dữ liệu. Phân quyền được dùng truy cập một phần của hệ thống cơ sở dữ liệu.	XN-BM 5.9.1/03
5.2.3. Quyền truy cập cho lãnh đạo		
1	Lãnh đạo Khoa có thể tạo các ghi chú cho các bản ghi, có quyền tạo/chỉnh sửa thông tin nhóm do mình phụ trách.	XN-BM 5.9.1/03
2	Lãnh đạo có thể xuất toàn bộ thông tin do mình phụ trách.	XN-BM 5.9.1/03
5.2.4. Quyền truy cập cho người nhập liệu		
1	Người nhập liệu có quyền tạo/sửa bản ghi trong cùng nhóm	XN-BM 5.9.1/03
2	Người nhập liệu không thể xóa bất kỳ bản ghi nào nhưng có thể đề xuất xóa bản ghi đó nếu cần và ghi rõ lý do. Khi đó cán bộ đầu mối sẽ chấp nhận xóa bản ghi, bản ghi đó không thực chất xóa khỏi cơ sở dữ liệu mà được chuyển sang thể ẩn.	XN-BM 5.9.1/03
3	Có thể xuất dữ liệu của nhóm làm việc.	
5.3. Quản lý hệ thống thông tin		
5.3.1. Đối với quản trị		
1	Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định.	
2	Duy trì hoạt động của máy tính dành cho nhập liệu (nếu có), mỗi bộ phận xét nghiệm có 01 máy tính dành riêng cho nhập liệu. Nếu có máy tính chủ (server) đảm bảo phải có phân quyền cho người truy cập.	
5.3.2. Đối với người nhập liệu		
1	Không được tự ý cài đặt/gỡ bỏ/thay đổi nội dung phần mềm trên máy tính nhập liệu/máy tính kết nối	

	với thiết bị xét nghiệm khi chưa được sự đồng ý của người quản lý.	
2	Đối với máy tính cài đặt chương trình điều khiển thiết bị thì phải kiểm tra tính toàn vẹn của chương trình trước khi vận hành.	
5.4. Phần mềm quản lý thông tin		
1	Khoa có thể tự phát triển ứng dụng quản lý dữ liệu riêng; hoặc sử dụng chung với Khoa khác; hoặc sử dụng phần mềm thương mại; hoặc phần mềm được cung cấp bởi các đơn vị/tổ chức.	
1	Trước khi đưa vào sử dụng Khoa phải biên soạn hướng dẫn sử dụng phần mềm và đánh giá tính khả thi của phần mềm: đáp ứng được nhu cầu về quản lý thông tin so với phần mềm đang sử dụng hoặc hệ thống văn bản đang sử dụng.	
5.5. Đánh giá phần mềm		
1	Đánh giá phần mềm có thể dựa trên tiêu chí cơ bản và/hoặc nâng cao hoặc liệt kê các tính năng của Ứng dụng quản lý thông tin Khoa Vi sinh-miễn dịch của nhà cung cấp	XN-BM 5.9.1/01
2	Tiêu chí cơ bản: + Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng + Giao diện thiết kế hợp lý: thuận tiện cho thao tác nhập liệu theo trình tự + Tính đồng nhất của dữ liệu nhập: tên tỉnh/thành, quận/huyện, xã phường	
3	Tiêu chí nâng cao + Truy vấn thông tin dễ dàng + Thống kê số liệu + Giám sát người dùng, thay đổi nội dung dữ liệu	

	+ Các tiêu chí khác nếu có	
5.6. Sao lưu dự phòng		
5.6.1. Sao lưu hệ thống tài liệu / hồ sơ		
1	Phải được sao lưu định kỳ tối thiểu 3 tháng 1 lần, phải đảm bảo đã kiểm tra tính đồng nhất của các bản sao lưu đó.	XN-BM 5.9.1/02
2	Mỗi lần sao lưu phải kiểm tra nội dung sao lưu bằng cách tạo một tập tin dạng chữ đơn giản (tập tin text của hệ điều hành). Tên tập tin sẽ là “Kiểm tra sao lưu” và nội dung sao lưu sẽ là năm.tháng.ngày: đã kiểm tra (chú ý nội dung viết tiếng việt không dấu, vd: 2022.04.07: da kiem tra). Những lần kiểm tra sao lưu tiếp theo thì chèn thêm hàng lên trên của lần kiểm tra sao lưu trước.	XN-BM 5.9.1/02
5.6.2. Sao lưu phần mềm quản lý thông tin		
1	Phải được sao lưu định kỳ tối thiểu 3 tháng 1 lần, phải đảm bảo đã kiểm tra tính đồng nhất của các bản sao lưu đó.	XN-BM 5.9.1/02
2	Nội dung sao lưu phải có ít nhất 5 bản ghi khác nhau và 5 trường dữ liệu (các trường dữ liệu của các bản ghi phải giống nhau) + Trường dữ liệu: tên; tuổi; mã bệnh phẩm; loại mẫu; phương pháp xét nghiệm; kết quả xét nghiệm ... + Bản ghi: bao gồm nhiều trường dữ liệu	XN-BM 5.9.1/02
3	Thay đổi nội dung sao lưu: + Có thể thay đổi nhưng không được dưới số lượng tối thiểu cho bản ghi / trường dữ liệu + Đảm bảo giữa các lần sao lưu phải có tối thiểu 60 % bản ghi/trường dữ liệu giống với lần sao lưu trước	XN-BM 5.9.1/02

	và các thay đổi mới sau 2 lần sao lưu kể từ khi thay đổi nội dung sao lưu mới được thay thế nội dung sao lưu mới.	
5.7. Bảo vệ hệ thống thông tin:		
5.7.1. Môi trường và tiện nghi:		
1	Máy tính phải đảm bảo sạch sẽ, thực hiện chế độ bảo trì, đặt ở vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, phòng cháy và chữa cháy.	
2	Dây điện và áp điện được bảo vệ thích hợp nếu đặt trong khu vực lối đi.	
3	Cần có nguồn điện cung cấp liên tục.	
4	Thông tin phải được bảo vệ, tránh truy cập trái phép.	
5.7.2. Phần cứng và phần mềm		
1	Cần định kì bảo dưỡng các phần cứng của máy tính (1 tháng 1 lần)	
2	Cần kiểm tra hệ thống sau mỗi lần bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hoặc thay đổi về phần cứng phần mềm hệ thống theo hướng dẫn.	
3	Bộ phận IT cần có một hệ thống máy tính thứ 2 để back up dữ liệu để phòng trường hợp xảy ra sự cố bất thường (như cháy nổ hệ thống). Các lỗi phát hiện khi sao lưu phải được lập thành văn bản và báo cáo với trưởng Khoa.	
4	Mỗi thay đổi phần cứng và phần mềm hệ thống cần phải được kiểm tra, xác nhận của Trưởng Khoa.	
5.7.3. An ninh hệ thống:		
1	Cần phải có biện pháp bảo vệ chương trình máy tính để ngăn ngừa người sử dụng ngẫu nhiên hoặc trái phép.	
2	Chỉ người có trách nhiệm mới được sử dụng máy	

	tính. Chỉ những xét nghiệm viên được Trưởng Khoa phân công mới được truy cập dữ liệu bệnh phẩm và nhập kết quả xét nghiệm hoặc thay đổi kết quả xét nghiệm.	
3	Cần đặt mật khẩu cho riêng từng máy để tránh truy cập trái phép hệ thống thông tin.	

5.8. Kế hoạch ứng phó khi có sự cố CNTT

1	Khi có sự cố CNTT xảy ra. Nhân viên IT có trách nhiệm thông báo cho các các khoa phòng và bộ phận tiếp đón.	
2	Khoa Vi sinh-Miễn dịch gửi tới các khoa, phòng phiếu yêu cầu xét nghiệm ghi tay theo mẫu của bệnh viện.	
3	Khi lấy mẫu thì nhân viên tổ lấy mẫu ghi đầy đủ thông tin: số thứ tự, họ và tên, tuổi của khách hàng lên ống lấy mẫu và phiếu yêu cầu xét nghiệm.	
4	Nhận mẫu và chỉ định xét nghiệm trên máy theo chế độ thủ công.	
5	Sau khi có kết quả xét nghiệm thì kết quả được nhập vào Phiếu kết quả xét nghiệm.	
6	Kết quả sẽ được trả bằng bản cứng cho người yêu cầu xét nghiệm. Photo giữ lại 1 bản kết quả tại khoa.	

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Quản lý thông tin. Thời gian lưu 5 năm.

- Phiếu đề xuất yêu cầu phần mềm XN-BM 5.9.1/01
- Phiếu kiểm tra sao lưu cơ sở dữ liệu XN-BM 5.9.1/02
- Danh sách cán bộ truy cập phần mềm XN-BM 5.9.1/03
- Phiếu đánh giá hệ thống mạng LIS sau nâng cấp XN-BM 5.9.1/04

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn XN-QTQL 5.2.02

Quy trình Quản lý thông tin	Mã số: XN-QTQL 5.9.01
-----------------------------	-----------------------

- Quy trình bảo mật thông tin khách hàng XN-QTQL 5.9.2
- Quy trình báo cáo kết quả XN-QTQL 5.8.11

8. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

Phiên bản: 1.0	Trang 9/9
Ngày ban hành: .../01/2026	